

Avaliação da dor crônica na Atenção Primária à Saúde: um guia prático para profissionais de todo o Brasil.

Este material foi feito pensando em você, profissional que está na linha de frente do cuidado, atendendo pessoas de todas as regiões do país.

A dor crônica é um desafio enorme, não é mesmo? Nós sabemos que não é fácil lidar com essa situação no dia a dia, mas, com as ferramentas certas, uma abordagem ampliada e com escuta cuidadosa, podemos fazer a diferença na vida das pessoas.



Baixe e imprima este material em formato A4.



Por que a dor crônica é um problema tão grande?

Para começar, é essencial revisar os números.

No Brasil, a dor crônica afeta cerca de 40% da população adulta, sendo que 25% sofrem com essa condição diariamente (Brasil, 2024). A dor crônica intensa (intensidade ≥ 8) atinge cerca de 10% dos casos, enquanto 5% estão associados a limitações graves ou generalizadas; já a fibromialgia acomete 2,5% da população (Brasil, 2024). As regiões mais afetadas são a lombar, joelho, ombro, cabeça, dorso e os membros inferiores (Correia; Duncan, 2022), impactando substancialmente a qualidade de vida e a capacidade funcional da população. Imagina o impacto disso na vida dessas pessoas! Além da dor em si, muitos pacientes enfrentam dificuldades para trabalhar, cuidar da família e até mesmo para dormir (Caumo, 2022; Correia; Duncan, 2022).

E não para por aí! A dor crônica é a principal causa de afastamento do trabalho e aposentadoria precoce, além de gerar altos custos para o sistema de saúde (Correia; Duncan, 2022). É por isso mesmo que se precisa estar preparado para oferecer o melhor cuidado possível a essas pessoas.

A essa altura do curso, vocês já compreenderam que a dor é uma experiência única!



Cada pessoa sente a dor de um jeito diferente. O que influencia essa experiência?

Fatores biológicos

Genética, saúde física, etc.

Fatores psicológicos

Humor, crenças, medos, etc.

Fatores sociais

Apoio da família e amigos, trabalho, etc.

Por isso, não se pode tratar todos as pessoas atendidas da mesma forma. É necessário entender a história de cada um para oferecer um cuidado realmente eficaz (Correia; Duncan, 2022).

Ferramentas Práticas para Avaliar a Dor

Na correria do dia a dia na área da saúde, e também na Atenção Primária à Saúde (APS), algumas ferramentas que ajudem a entender a dor da pessoa atendida de forma rápida e eficiente são essenciais. Algumas opções são:

Qualificação da Dor (PQRST)

Investigue o que provoca ou alivia a dor (P), pergunte sobre a qualidade da dor — se é, por exemplo, uma "queimação", um "choque" ou uma "pontada" (Q), identifique a região exata onde a dor ocorre e se há irradiação para outras áreas do corpo (R), a severidade da dor (S), e pergunte, ainda, quando a dor começou, se é contínua ou intermitente, se há padrão de piora ao longo do dia, e há quanto tempo está presente (T) (Correia; Duncan, 2022).

Escalas de Dor

Use escalas simples, como a numérica (de 0 a 10) ou a de faces (para crianças ou pessoas com dificuldade de comunicação), para medir a intensidade da dor (Caumo, 2022).

Questionários

Aplique questionários para avaliar o impacto da dor na vida da pessoa atendida, como o Perfil de Dor Crônica, o Inventário Breve de Dor (BPI) e a Escala Graduada de Dor Crônica (Caumo, 2022).

Inventário de Sensibilização Central (CSI)

Esse questionário pode ajudar a identificar pacientes com sensibilização central, que é quando o sistema nervoso fica "hipersensível" e amplifica a dor (Caumo, 2022).

Escala de Catastrofização da Dor (PCS)

Essa escala avalia se o paciente tem pensamentos negativos exagerados sobre a dor, o que pode piorar o quadro (Caumo, 2022).



Exame Físico: o que procurar?

Além de conversar com a pessoa atendida, o exame físico é fundamental. Esteja atento a:



Articulações

Veja se há inchaço, vermelhidão ou dificuldade/restrições de movimento (Correia; Duncan, 2022).



Sistema Nervoso

Avalie a sensibilidade, força muscular e reflexos (Correia; Duncan, 2022).



Músculos

Procure por pontos de tensão (gatilhos) e sensibilidade (Correia; Duncan, 2022).

O que há de errado com a abordagem tradicional?

Muitas vezes, o foco recai apenas na causa física da dor, esquecendo-se de que o fenômeno é muito mais complexo. A abordagem tradicional pode levar a:

Exames desnecessários

Pedir muitos exames sem motivos claros pode gerar ansiedade e até iatrogenia (prejuízo causado pelo tratamento).

Falta de atenção aos fatores emocionais e sociais

Ignorar o que se passa na vida da pessoa dificulta o tratamento.

Foco no médico, não no paciente

A pessoa atendida precisa ser a protagonista do seu tratamento, e não apenas um "espectador".

É preciso mudar essa visão!

A dor crônica é uma doença complexa, que exige uma abordagem individualizada que considere todos os aspectos da pessoa.



Recomendações para a Prática e Reflexões Essenciais

A avaliação da dor crônica na APS é um processo complexo e multifacetado, que exige uma abordagem individualizada e centrada na pessoa.

Ao longo desta cartilha, foi explorada a importância de compreender a dor como uma experiência subjetiva, moldada por fatores biológicos, psicológicos e sociais (Correia; Duncan, 2022; Raja *et al.*, 2020). Foram apresentadas ferramentas práticas para a avaliação, como a qualificação da dor (PQRST), escalas de intensidade, questionários multidimensionais e o exame físico direcionado (Caumo, 2022; Correia; Duncan, 2022).

É fundamental reconhecer as limitações da abordagem tradicional, que muitas vezes se concentra apenas na causa física da dor e negligencia os aspectos emocionais, sociais e comportamentais (Caumo, 2022; Correia; Duncan, 2022). Além disso, é crucial estar atento aos riscos da medicalização excessiva e à falta de preparo para lidar com populações específicas.

Cuidado com a medicalização excessiva!

Opioides: a "escada analgésica" da OMS, embora útil em dor oncológica, foi mal adaptada para dor crônica não oncológica, aumentando os riscos de dependência e outros efeitos adversos (Caumo, 2022).

Anti-inflamatórios Não Esteróides (AINEs): apesar de pouco eficazes em lombalgia crônica, os AINEs ainda são amplamente prescritos, expondo os pacientes a riscos gastrointestinais, cardiovasculares e renais (Correia; Duncan, 2022).

Atenção às populações especiais!

Idosos: a dificuldade em comunicar a dor, somada ao risco de polifarmácia, exige uma abordagem ainda mais cuidadosa e individualizada (Correia; Duncan, 2022).

Crianças: a limitação em usar escalas numéricas padrão requer a utilização de ferramentas adaptadas e a consideração dos aspectos emocionais e comportamentais (Correia; Duncan, 2022).



Recomendações para a Prática

Para oferecer um cuidado mais eficaz e humanizado às pessoas com dor crônica atendidas na APS, seguem algumas sugestões:



Comece pela escuta ativa

Utilize o Guia de Entrevista de Calgary-Cambridge para estabelecer uma relação de confiança com a pessoa com dor crônica e compreender sua experiência de dor (Correia; Duncan, 2022).



Priorize ferramentas simples

Utilize o PQRST (Provocação, Qualidade, Região, Severidade, Tempo) e o DN4 (para dor neuropática) como ferramentas de triagem antes de solicitar exames complexos (Caumo, 2022; Correia; Duncan, 2022).



Identifique fatores psicossociais

Esteja atento às "bandeiras amarelas", como desemprego, depressão, conflitos familiares e dificuldades financeiras, que podem influenciar a experiência da dor (Correia; Duncan, 2022).



Evite tratamentos baseados apenas em exames de imagem

Lembre-se de que a dor é uma experiência subjetiva e que os exames complementares devem ser solicitados com critério e em conjunto com a avaliação clínica (Correia; Duncan, 2022).



Incentive abordagens não farmacológicas

Estimule a prática de exercícios físicos, a terapia cognitivo-comportamental, técnicas de relaxamento e outras abordagens não medicamentosas que podem auxiliar no controle da dor e na melhora da qualidade de vida (Caumo, 2022).



E agora?

Estamos chegando ao fim desta cartilha, mas a jornada do cuidado à dor crônica está apenas começando. Lembre: cada pessoa é única e merece uma abordagem individualizada e compassiva.

Avaliar a dor crônica na APS exige mais do que diagnosticar – é preciso acolher, compreender e empoderar a pessoa atendida.

A avaliação abrangente da dor crônica pode parecer um desafio na rotina da APS, especialmente diante das limitações de tempo, alta demanda e múltiplas queixas por consulta. No entanto, com pequenas adaptações e uma estratégia focada, é possível realizar um atendimento eficaz, centrado na pessoa e baseado em evidências, mesmo em consultas mais curtas.

A tabela a seguir compara um modelo ideal de consulta em dor crônica com uma versão adaptada para o tempo e os recursos da APS, oferecendo sugestões práticas para garantir uma escuta qualificada, uma avaliação biopsicossocial e a construção de um plano de cuidado realista e humanizado.



TABELA COMPARATIVA: CONSULTA EM DOR CRÔNICA MODELO IDEAL (40 min) vs. APS (20 min)

ETAPAS	CONSULTA IDEAL (40-60 min)	CONSULTA MÉDIA NA APS (15-20min)
Tempo de Duração	40 minutos	20 minutos
Preparação	Ambiente totalmente silencioso, revisão detalhada do prontuário	Ambiente com mínimas interrupções, revisão rápida do prontuário
Início (0-5 min)	Acolhimento completo + história aberta sem pressão	Adaptação: foco imediato em [S]ensações e [E]moções (ex.: "Onde dói? Como isso a faz se sentir?")
Meio (6-30 min vs. 6-15 min)	Exploração profunda: todas as 5 dimensões SCEBS (S,C,E,B,S) ● 3-4 perguntas por dimensão ● exame físico detalhado	Foco estratégico: ● 2 perguntas-chave por dimensão (ex.: "O que piora? Como afeta seu dia?") ● exame físico direcionado
Escuta Ativa	5 minutos ininterruptos para narrativa livre	2 minutos ininterruptos (prioriza queixas principais)
Empatia	Validação emocional: prolongada + exploração de traumas	Frases curtas de validação: "Isso deve ser muito difícil."
Final (31-40 vs. 16-20 min)	Pactuação detalhada: ● plano terapêutico multifocal ● encaminhamentos complexos	Pactuação objetiva: ● 1-2 prioridades (ex.: sono ou mobilidade) ● rede de segurança simplificada
Ferramentas	Uso de genograma, escalas validadas, diagramas	Uso de desenhos rápidos ou metáforas (ex.: "A dor crônica é como um alarme que dispara sem perigo real.")
Registro	Prontuário detalhado com todas as dimensões	Registro focado nos pontos-chave (S+E+B)

Que tal começar a colocar em prática o que se aprendeu hoje?



Referências

BRASIL. Ministério da Saúde. **Protocolo clínico e diretrizes terapêuticas – Dor crônica**. Portaria Conjunta SAES/SAPS/SECTICS/MS nº 1, de 22 de agosto de 2024. Brasília: Ministério da Saúde, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/protocolos/dorcronica-1.pdf>. Acesso em: 16 jan. 2026.

CAUMO, W. Dor crônica e sensibilização central. *In*: DUNCAN, B. B. *et al.* **Medicina ambulatorial: condutas de atenção primária baseadas em evidências**. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2022.

CORREIA, M. P. V.; DUNCAN, M. S. Abordagem geral da dor. *In*: DUNCAN, B. B. *et al.* **Medicina ambulatorial: condutas de atenção primária baseadas em evidências**. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2022.

RAJA, S. N. *et al.* The Revised IASP definition of pain: concepts, challenges, and compromises. **Pain**, [s. l.], v. 161, n. 9, p. 1976-1982, 2020.

Ficha técnica

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Secretaria de Atenção Primária à Saúde - SAPS
Departamento de Promoção da Saúde - DEPROS
Coordenação de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde - COPICS

Coordenação Geral:

Paulo Roberto Sousa Rocha
COPICS/DEPROS/SAPS/MS
Daniel Miele Amado
COPICS/DEPROS/SAPS/MS

Equipe Técnica:

Nathalia Oliveira da Silva
COPICS/DEPROS/SAPS/MS

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

Reitoria

Ursula Rosa da Silva

Vice-Reitoria

Eraldo dos Santos Pinheiro

Coordenação Geral

Julieta Carriconde Fripp
Coordenadora da Cuidativa (Centro Regional de Referência em Cuidados Paliativos FAMED/UFPEL), Diretora da Faculdade de Medicina da UFPEL.

Coordenadora Adjunta

Simone da Fonseca Sanghi
Assistente Social da Cuidativa (Centro Regional de Referência em Cuidados Paliativos FAMED/UFPEL), Colaboradora dos processos de Gestão na Cuidativa.

Ficha técnica

CRÉDITOS DO CURSO

Coordenação Geral

Paulo Roberto Sousa Rocha
Julieta Carriconde Fripp
Simone da Fonseca Sanghi

Apoio Administrativo / Secretaria

Luciano Avila dos Santos

Coordenação de Conteúdo

Amirah Adnan Salman
Bárbara Cury Soubhia
Manuela Samir Maciel Salman

Consultoria e Revisão de Conteúdos

Amirah Adnan Salman
Andrea Cristina Lovato Ribeiro
Bárbara Cury Soubhia
Julieta Carriconde Fripp
Manuela Samir Maciel Salman
Nathalia Oliveira da Silva
Paulo Roberto Sousa Rocha
Simone da Fonseca Sanghi

Coordenação Pedagógica

Amirah Adnan Salman
Andrea Cristina Lovato Ribeiro
Bárbara Cury Soubhia
Manuela Samir Maciel Salman

Coordenação de Pesquisa e Relatórios

Luiz Augusto Facchini
Elaine Thumé
Elaine Tomasi

Coordenação de Mídias e Comunicação

Samir Salman
João Rocha Rodrigues
Luana Copini Jahn

Coordenação de Tecnologia e Informação

Alessander Osório

Coordenação da Produção

Alexandre Moretto Ribeiro
Andrea Cristina Lovato Ribeiro

Revisão Gramatical/Ortográfica e ABNT

Giulia M. Delazzeri

Coordenação de Atividades e Logística de Campo:

Paulo Roberto Sousa Rocha

Produção Audiovisual

Eduardo Dias Abreu

Assistente de Produção Audiovisual

Luciana Melo

Animação

Márlon Lima

Ilustração

Mario Cau
Barlo Moreira (cores)

Diagramação e Design Gráfico

Danielle Rossi

Design Web e Programação

Vando Pinto

CRÉDITOS DESTE RECURSO DIDÁTICO

Conteúdo

Rodrigo Macedo Pacheco